

Система органов кровообращения

Блок А (75%)_

ТЗ Форма 1'

В патогенезе коронарной недостаточности определяющим фактором является

{

~недостаточность оксигенации крови

~повышение потребности миокарда в кислороде

~несоответствие коронарного кровотока потребностям миокарда

~нарушение процессов обмена макроэргических фосфорных соединений в миокарда

=все перечисленное

}

Непосредственной причиной возникновения приступа стенокардии может быть {

~волнение

~выход на холод

~физическая нагрузка

~повышение артериального давления

=все перечисленное

}

Мужчина 47 лет в течение двух месяцев жалуется на сжимающие боли за грудиной, возникающие при ходьбе в среднем темпе через 500 м, или при подъеме по лестнице на 3-й этаж. данный случай стенокардии можно классифицировать как {

~нестабильная стенокардия

~промежуточная форма ишемической болезни сердца

=стабильная стенокардия напряжения.

~вариантная стенокардия

~впервые возникшая стенокардия

}

Мужчина 47 лет в течение двух месяцев жалуется на сжимающие боли за грудиной, возникающие при ходьбе в среднем темпе через 500 м, или при подъеме по лестнице кардиология на 3-й этаж. стенокардию у этого больного можно отнести к функциональному классу {

=I

~II

~III

~IV

~функциональный класс определить невозможно

}

В основе вариантной стенокардии лежит

~стенозирующий атеросклероз коронарных артерий

=спазм коронарных артерий

~тромбоз коронарных артерий

~повышение потребности миокарда в кислороде

~повышение вязкости крови

}

Причинами появления патологических органических шумов в сердце являются {

=органические поражения клапанного аппарата и отверстий сердца

~изменение тока крови в сосудах

~изменение вязкости крови

~первичные заболевания с истощением, гипотрофией

~расширения полостей сердца

}

Пик активности АСТ при остром инфаркте миокарда отмечается через {

~2-6 час

=1-2 суток

~3-4 суток

~4-6 суток

~6-8 суток

}

Дольше других при остром инфаркте миокарда удерживается повышенный уровень активности одного из следующих ферментов {

~миоглобина, тропонинов

~креатинкиназы МВ

~аланиновой трансаминазы (АЛТ)

~аспарагиновой трансаминазы (АСТ)

=лактатдегидрогеназы (ЛДГ)

}

Повреждающее действие стрептококка на соединительную ткань опосредовано через {

~токсины стрептококка

~накопление большого количества иммунных комплексов

~реакции гиперчувствительности немедленного типа (гуморальный иммунитет)

~реакции гиперчувствительности замедленного типа (клеточный иммунитет) с образованием антикардиальных антител

=все перечисленные механизмы

}

К частым и типичным симптомам первичного ревматизма не относятся {

~воспаление миокарда (миокардит)

~хорея

~артрит

~перикардит

=подкожные узелки

}

К основным диагностическим критериям ревматизма относят {

~кардит

~полиартрит

~кольцевидную эритему

~подкожные ревматические узелки

=все перечисленное

}

При ревматизме наиболее часто (не считая сердца) поражаются {

=суставы

~центральная нервная система

~почки

~кожа

~кожа

}

Электрокардиографическими признаками аортального стеноза являются все перечисленные, кроме {

~гипертрофии левого желудочка
~гипертрофии левого предсердия
~атриовентрикулярной блокады
=гипертрофии правого предсердия
~блокады левой ножки пучка Гиса
}

Электрокардиографическими признаками митрального стеноза являются все перечисленные, кроме {
~гипертрофии левого предсердия
~мерцательной аритмии
~гипертрофии правого желудочка
=гипертрофии левого желудочка
~поворота электрической оси сердца вправо
}

Основными методами диагностики многоклапанных пороков сердца являются все перечисленные, кроме {
~эхокардиографии
~электрокардиография
~рентгенографии
~катетеризации сердца
=сфигмографии
}

При ревматизме наблюдаются изменения следующих лабораторных параметров {
~содержания фибриногена
~активности трансаминаз
~показателя дифениламиновой реакции, сиаловых кислот
~появление С-реактивного белка
=всех перечисленных
}

Пульс tardus (медленный) и parvus (малый) характерен {
~для недостаточности трехстворчатого клапана
~для недостаточности митрального клапана
~для недостаточности аортального клапана
=для стеноза устья аорты

~для митрального стеноза
}

Значительное расширение сердца влево и вниз наблюдается при дилатации {
~правого предсердия
~правого желудочка
~левого предсердия
=левого желудочка
~правого и левого желудочков
}

Кровохарканье при пороках сердца чаще всего наблюдается: {
~при недостаточности митрального клапана
=при митральном стенозе
~при недостаточности аортального клапана
~при стенозе устья аорты
~при недостаточности трехстворчатого клапана
}

На экг ритм желудочковых сокращений (qrst) неправильный, зубец r отсутствует. это указывает на {
=мерцательную аритмию
~желудочковую экстрасистолию
~предсердную экстрасистолию
~синусовый ритм
~атриовентрикулярный ритм
}

Больной 48 лет жалуется на боли в эпигастральной области, слабость. ранее боли в животе не беспокоили. на экг зубец t и q в отведениях iii, avf глубокий, t отрицательный. заключение {
~инфаркт передней стенки левого желудочка
=инфаркт задней стенки левого желудочка
~остро возникшее ущемление грыжи пищеводного отверстия диафрагмы
~панкреатит
~аортит
}

Причиной возникновения систолического шума при недостаточности

митрального клапана является х

~ток крови из левого предсердия в левый желудочек во время систолы

=прохождение обратной волны крови из левого желудочка в левое предсердие через неплотно сомкнутые створки митрального клапана

~ток крови из левого желудочка в аорту

~ток крови через незакрытый артериальный (боталлов) проток

~увеличение конечного диастолического объема

}

Характерным признаком для стеноза устья аорты являются {

=систолический шум во втором межреберье справа

~систолический шум на верхушке сердца

~систолический шум во втором межреберье слева

~диастолический шум во втором межреберье справа от грудины

~диастолический шум на верхушке

}

Одним из наиболее важных моментов в диагностике ишемической болезни сердца является {

~аускультация сердца

=анамнез

~наличие блокады правой ножки пучка Гиса

~ЭКГ, произведенная в покое

~недостаточность кровообращения

}

Патогномоничным для стенокардии является {

~загрудинная боль при физической нагрузке без изменений ЭКГ

~желудочковая экстрасистолия после нагрузки

=приступообразная загрудинная боль и депрессия на ЭКГ сегмента S-T на 1 мм и более

~подъем сегмента S-T менее, чем на 1 мм

~увеличение зубца Q в III стандартном и aVF отведениях

}

При жалобах на загрудинные боли диагноз инфаркта миокарда можно установить при наличии следующих данных электрокардиографического исследования {

~ЭКГ не изменена

~атриовентрикулярная блокада I степени
~синусовая тахикардия
~патологическое отклонение электрической оси сердца
=ни в одном случае
}

Самым ранним электрокардиографическим признаком трансмурального инфаркта миокарда является {

~изменение комплекса QRS
~инверсия зубца T
~нарушение сердечного ритма
=подъем сегмента ST
~появление зубца Q
}

Прямые признаки заднего инфаркта миокарда на экг регистрируются в следующих отведениях {

~I, aVL, V1-V4
=II, III, aVF
~I, aVL, V5-V6
~aVL, V1-V2
~V1-V6
}

Что такое не q инфаркт {

~наличие клиники инфаркта и выраженного изменения Q
=инфаркт с изменениями в сегмента ST при нормальном или отсутствующим Q
~появление комплекса QS в двух и более отведениях
~byafhrn с ghbpyfrfvb блокада левой ножки пучка Гиса
~инфаркт с появлением Q в V 4-6
}

На экг при митральном стенозе выявляются {

=признаки гипертрофии правого желудочка и левого предсердия
~признаки гипертрофии левого желудочка
~блокада левой передней ветви пучка Гиса
~горизонтальное положение электрической оси сердца
~ничего из перечисленного

}

Причинами развития недостаточности аортального клапана могут быть все перечисленные, кроме {

- ~ревматизма
- ~расслаивающей аневризмы аорты
- ~инфекционного эндокардита
- =инфаркта миокарда
- ~сифилиса

}

Для какого порока характерен грубый систолический шум над всей предсердечной области, иррадиирующий в межлопаточное пространство {

- =коарктация аорты
- ~стеноз устья аорты
- ~стеноз митрального клапана
- ~недостаточность аортального клапана
- ~незаращение артериального протока

}

Уровень артериального давления определяется {

- ~работой сердца (минутным объемом)
- ~венозным кровенаполнением
- ~периферическим сосудистым сопротивлением
- ~первым и вторым факторами
- =первыми и третьим факторами

}

Назовите наиболее частую причину хронической сердечной недостаточности {

- ~ревматические пороки сердца
- =ИБС
- ~артериальная гипертензия
- ~миокардиты и миокардиодистрофии
- ~первичные нарушения обменных процессов в миокарде

}

Электрокардиографические признаки синусовой брадикардии {

- =сохранение правильного синусового ритма с частотой 40-59 в минуту

~колебания продолжительности интервалов Р-Р превышают 0.15 с при частоте синусового ритма 60-90 в минуту
~наличие "узкого" комплекса QRS
~отсутствие зубцов Р на ЭКГ
~частота ритма 30 в минуту
}

Признаком предсердной экстрасистолии является {
=преждевременное появление зубца Р, отличающегося от Р остальных циклов, со следующим за ним комплексом QRS
~наличие полной компенсаторной паузы после преждевременного сокращения
~отрицательные зубцы Р перед комплексами QRS, идущими в регулярном ритме
~зубец Р следует за комплексом QRS
~все перечисленное
}

Какова максимальная амплитуда зубца р в норме {
~1мм
=2мм
~3мм
~4мм
~5мм
}

Какова продолжительность интервала р-q в норме {
~0,01-0,06 сек
~0,06-0,12 сек
=0,12-0,2 сек
~0,18-0,24 сек
~0,24-0,30 сек
}

Причинами появления трехчленного ритма наиболее часто является {
=митральный стеноз
~недостаточность двухстворчатого клапана
~снижение давления в аорте и легочной артерии
~аортальный стеноз

~недостаточность аортальных клапанов
}

Электрокардиографическим признаком желудочковой экстрасистолии является {

~уширенный комплекс QRS (0.12 с), который следует за зубцом Р
~неполная компенсаторная пауза после экстрасистолы
=преждевременное появление широкого экстрасистолического комплекса без предшествующего зубца Р, компенсаторная пауза полная
~наличие зубца Р перед экстрасистолическим комплексом QRS
~все перечисленное
}

Какова максимальная продолжительность комплекса qrs в норме {

~0,01 сек
~0,02 сек
~0,04 сек
~0,08 сек
=0,10 сек
}

Какая скорость движения записывающей бумаги является стандартной при снятии ЭКГ {

~10 мм/сек
~25 мм/сек
=50 мм/сек
~100 мм/сек
~200 мм/сек
}

Симптомами митрального стеноза в стадии начинающейся сердечной недостаточности обычно являются {

~одышка
~приступы удушья
~кровохарканье
~сердцебиение
=все перечисленные
}

С митральным стенозом связаны все перечисленные клинические симптомы, кроме {

- ~болеи за грудиной
 - ~сердцебиений
 - ~приступов удушья
 - ~кровохарканья
 - =тошноты и рвоты
- }

"Грудная жаба" при отсутствии поражения коронарных артерий чаще всего встречается {

- ~при митральном стенозе
 - ~при митральной недостаточности
 - ~при стенозе устья легочной артерии
 - =при стенозе устья аорты
 - ~при недостаточности аортального клапана
- }

Быстрый подъем пульсовой волны с последующим быстрым ее спаданием характерен {

- ~для митрального стеноза
 - ~для митральной недостаточности
 - ~для аортального стеноза
 - =для аортальной недостаточности
 - ~для коарктации аорты
- }

По современным представлениям, электрофизиологическим механизмом развития мерцательной аритмии является нарушение {

- =синатриальной проводимости
 - ~внутрипредсердной проводимости
 - ~внутрижелудочковой проводимости
 - ~атриовентрикулярной проводимости
 - ~проведения импульса на уровне волокон Пуркинье в желудочках
- }

К клиническим симптомам недостаточности кровообращения относится все перечисленное, кроме {

~появления цианоза губ при физической нагрузке
~появления сухих хрипов в легких
=увеличения диуреза
~появления никтурии
~одышки и сердцебиения, возникающих при физической нагрузке
}

Недостаточность кровообращения характеризуется появлением одышки, утомляемости, сердцебиения только при нагрузке. имеется гипертрофия миокарда. трудоспособность снижена. определите стадию недостаточности кровообращения по стражеско-василенко {
=I стадия
~IIА стадия
~IIБ стадия
~III стадия
~III стадия
}

Одышка и тахикардия постоянные и усиливаются после небольшой нагрузки, имеется миогенная дилатация сердца, застойные явления в малом круге, небольшое увеличение печени, трудоспособность больного резко ограничена. определите стадию недостаточности кровообращения по стражеско-василенко {
~1 стадия
~2 стадия А
~2 стадия Б
=3 стадия
~4 стадия
}

Одышка и тахикардия постоянные и усиливаются после умеренной нагрузки, имеется небольшое увеличение печени, трудоспособность больного умеренно ограничена. определите стадию недостаточности кровообращения по стражеско-василенко {
~1 стадия
=2 стадия А
~2 стадия Б
~3 стадия
~4 стадия

}

Одышка и тахикардия возникают после длительной нагрузки, печень не увеличена, трудоспособность ограничена в малой степени. определите стадию недостаточности кровообращения по { стражеско-василенко

=1 стадия

~2 стадия А

~2 стадия Б

~3 стадия

~4 стадия

}

Одышка и тахикардия возникают после небольшой нагрузки, имеется небольшое увеличение печени, трудоспособность больного ограничена. определите стадию недостаточности кровообращения по стражеско-

василенко {

~I стадия

=IIА стадия

~IVстадия

~IVстадия

~IVстадия

}

У больного имеются застойные явления в малом и большом круге кровообращения, увеличенная (застойная) печень, периферические отеки. при проведении кардиальной и мочегонной терапии симптомы недостаточности кровообращения уменьшаются. трудоспособность утрачена.

определите стадию недостаточности кровообращения по стражеско-василенко {

~I стадия

~IIА стадия

=IIБ стадия

~III стадия

~IV стадия

}

У больного имеются симптомы стойкой хсн. определяются цирроз печени, выраженные периферические отеки, асцит, гидроторакс, кахексия. определите стадию недостаточности кровообращения по стражеско-

василенко {
~I стадия
~IIA стадия
~IIB стадия
=III стадия
~IV стадия
}

К стандартным отведениям экг относятся {
=I, II, III
~aVR, aVL, aVF
~V1, V2, V3
~V4, V5, V6
~дорзалис, антериор, инфериор
}

Для левожелудочковой недостаточности характерны все перечисленные симптомы, за исключением {
~одышки
~"ритма галопа"
=набухания шейных вен
~большое количество влажных симметрично расположенных хрипов в нижних отделах легких
~сердечной астмы
}

Во втором межреберье справа от грудины выслушивается систолический шум нарастающе-убывающего характера, проводящийся на сосуды шеи. при каком пороке это может быть {
~митральный стеноз
~недостаточность митрального клапана
=аортальный стеноз
~недостаточность клапанов аорты
~недостаточность трехстворчатого клапана
}

На верхушке выслушивается систолический шум убывающего характера, занимающий всю систолу и проводящийся в левую подмышечную область. при каком заболевании это может быть {

~митральный стеноз
=недостаточность митрального клапана
~аортальный стеноз
~недостаточность клапанов аорты
~недостаточность трехстворчатого клапана
}

Во втором межреберье справа от грудины выслушивается диастолический шум убывающего характера, начинающийся сразу после 2 тона и занимающий $\frac{2}{3}$ диастолы. шум проводится в точку боткина-эрба и на верхушку. при каком заболевании это может быть {

~митральный стеноз
~недостаточность митрального клапана
~аортальный стеноз
=недостаточность клапанов аорты
~недостаточность трехстворчатого клапана
}

На верхушке выслушивается диастолический шум, начинающийся через небольшой интервал после 2 тона, убывающего характера, продолжающийся всю диастолу. шум имеет пресистолическое усиление, никуда не проводится. при каком заболевании это может быть {

=митральный стеноз
~недостаточность митрального клапана
~аортальный стеноз
~недостаточность клапанов аорты
~недостаточность трехстворчатого клапана
}

Где в норме расположена верхняя граница относительной тупости сердца {

~на уровне II ребра
~на уровне II межреберья
=на уровне III ребра
~на уровне III межреберья
~на уровне IV ребра
}

Откуда начинают перкутировать для определения левой границы сердца {

~от левой срединной линии влево

~от левой стеральной линии влево
~от левой парастеральной линии вправо
~левой срединно-ключичной линии вправо
=по левой передней подмышечной линии вправо
}

Пропалс митрального клапана проявляется {
~усилением I тона
~ослаблением I тона
=мезосистолическим шумом на верхушке при сохранении I тона
~систолическим шумом на верхушке и ослаблением I тона
~диастолическим шумом на верхушке
}

Как изменится ii тон сердца при повышении давления в легочной артерии в сочетании с гипертрофией правого желудочка {
~ослабление II тона на легочной артерии
=акцент II тона на легочной артерии
~ослабление I тона на легочной артерии
~акцент I тона на верхушке
~
}

Наиболее характерный экг-признак вариантной стенокардии {
~горизонтальная депрессия ST
~депрессия ST выпуклостью кверху и несимметричный зубец T
=подъем ST выше изолинии
~глубокие зубцы Q
~зубцы QS
}

Какой из перечисленных методов исследования является наиболее важным для диагностики стенокардии в сомнительных случаях {
~ЭКГ
=ЭКГ с велоэргометрией
~фонокардиография
~эхокардиография
~холтеровское мониторирование
}

Что такое острый коронарный синдром {

~типичный инфаркт миокарда

~затяжная стенокардия

~вариантная стенокардия

=типичный для инфаркта миокарда болевой синдром при отсутствии изменений со стороны зубцов и интервалов не Q инфаркт

~типичный для инфаркта миокарда болевой синдром при отсутствии изменений со стороны зубцов и интервалов не Q инфаркт

}

Диастолический шум при митральном стенозе {

~иррадирует в левую подмышечную область

~лучше выслушивается в положении на правом боку

~сопровождается третьим тоном

=лучше выслушивается в положении на левом боку с задержкой дыхания в фазе выдоха

~лучше выслушивается в вертикальном положении

}

У больного 42 лет обнаружено значительное смещение границ относительной тупости сердца влево, усиление верхушечного толчка, выраженный симптом систолического дрожания во 2-м межреберье справа от грудины и там же ослабление 2-го тона. какой из нижеперечисленных аускультативных феноменов непременно должен иметь место у данного больного {

~диастолический шум на верхушке

=систолический шум во 2 точке с проведением на сосуды шеи

~диастолический шум над аортой

~систолический шум у мечевидного отростка

~систолический шум у мечевидного отростка

}

Пациент 19 лет направлен на обследование с предположительным диагнозом митрального порока сердца. при осмотре был выявлен систолический шум на верхушке сердца. какой метод обследования наиболее информативен для подтверждения или исключения диагноза порока сердца {

~ЭКГ

=эхокардиография

~рентгеноскопия грудной клетки
~исследование крови на титры антистрептококковых антител
~ни один из перечисленных методов
}

Как изменяется АД при аортальной недостаточности {
~не изменяется
~повышается только систолическое
~повышается только диастолическое
=повышается систолическое АД и понижается диастолическое
~понижается систолическое АД и повышается диастолическое
}

Какой из перечисленных признаков характерен для митрального стеноза {
~систолический шум на верхушке сердца
~ослабленный 1-й тон на верхушке
~протодиастолический шум во 2-м межреберье справа
=диастолический шум с пресистолическим усилением на верхушке
~ослабленный 2-й тон во 2-м межреберье справа
}

Недостаточность митрального клапана может развиваться в результате {
~ревматизма
~инфаркта миокарда
~атеросклероза сердца
~инфекционного эндокардита
=всех вышеперечисленных заболеваний
}

Какой признак не характерен для аортальной недостаточности {
~пульсация зрачков
=снижение пульсового давления
~быстрый и высокий пульс
~высокое систолическое АД
~повышение сердечного выброса
}

Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия может развиваться в результате {

=ревматизма
~инфаркта миокарда
~травмы грудной клетки
~инфекционного эндокардита
~всех вышеперечисленных заболеваний
}

Протодиастолический шум при митральной недостаточности возникает вследствие {
~активной систолы предсердий
~появления мерцательной аритмии
=Наличия высокого градиента давления "левое предсердие - левый желудочек" в начале диастолы
~митральной регургитации
~растяжения левого предсердия
}

Какой шум характерен для аортального стеноза
=пансистолический
~протосистолический
~мезосистолический
~пресистолический
~протодиастолический
}

Какой признак патогномоничен для левожелудочковой недостаточности {
~набухание шейных вен
~асцит
~увеличение печени
=ортопноэ
~отеки на ногах
}

Особенность пульса при аортальной недостаточности {
~брадикардия
~мерцательная аритмия
~малый, медленный
=высокий, скорый
~тахикардия

}

Какое соединение электродов соответствует i стандартному отведению {

~левая рука - левая нога

=левая рука - правая рука

~левая рука - правая нога

~правая рука - левая нога

~правая рука - правая нога

}

К какой форме стенокардии относятся боли, возникающие у людей при умственной работе или при длительном сидячем положении {

~напряжения

=покоя

~вариантная

~покоя и напряжения

~нестабильная

}

Какие из перечисленных механизмов гипоксии миокарда имеют место при ишемической болезни сердца {

~артериальная гипоксемия

=недостаточное поступление кислорода

~усиление потребления кислорода

~снижение утилизации кислорода

~снижение утилизации кислорода

}

В каком грудном отведении располагается переходная зона зарисовки экг комплекса в норме {

~V1

~V2

=V3

~V4

~V5

}

Что наиболее характерно для распознавания мерцательной аритмии {

~частота желудочковых комплексов более 120 в минуту

=отсутствие зубцов Р
~наличие преждевременных комплексов QRS
~укорочение интервалов Р-Q
~наличие дельта-волны
}

В каких пределах колеблется угол альфа при нормальном положении электрической оси сердца {
~0 - +30
=30 - +60
~70 - +90
~90 - +120
~120 - +150
}

Какие из перечисленных симптомов позволяют заподозрить при наличии митрального стеноза сопутствующую ему митральную недостаточность {
=выраженный систолический шум, непосредственно примыкающий к I тону
~тон открытия митрального клапана
~громкий I тон
~ослабленный I тон
~трехчленный ритм
}

Какой симптом объединяет такие заболевания, как анемия, тиреотоксикоз, пролапс митрального клапана, недостаточность митрального клапана {
~диастолический шум на верхушке
~систолодиастолический шум
~шум Флинта
=систолический шум на верхушке
~шум Грэхема-Стила
}

Какой из перечисленных признаков характерен для митральной недостаточности {
~пульсация печени
~астеническая конституция
=увеличение сердца влево
~систолическое дрожание во II межреберье справа

~пальпаторно выявляемое дрожание у левого края грудины
}

Какой симптом характерен для внешнего вида больных со стенозом устья аорты {

~диффузный цианоз кожных покровов
~акроцианоз
=бледность кожных покровов
~симптом Мюссе
~"пляска каротид"
}

При каком пороке наблюдается максимальная гипертрофия миокарда левого желудочка {

~недостаточность аортального клапана
=стеноз устья аорты
~недостаточность митрального клапана
~стеноз митрального клапана
~недостаточность трикуспидального клапана
}

Какие изменения пульса характерны для больных со стенозом устья аорты

~редкий
~частый
~высокий и твердый
=малый и медленный
~быстрый (подъем и быстрое падение пульсовой волны)
}

Какое соединение электродов соответствует ii стандартному отведению {

~левая рука - левая нога
~левая рука - правая нога
~правая рука - правая нога
~левая рука - правая рука
=правая рука - левая нога
}

Какой электрод является активным в отведении avf {

~правая рука

~левая рука
~правая нога
=левая нога
~грудная клетка
}

Где накладываются электроды для снятия V 3-5 {
~четвертое межреберье
~четвертое ребро
~пятое ребро
=пятое межреберье
~шестое межреберье
}

Каково соотношение зубцов r при нормальном положении электрической оси сердца {
~ $R_1 > R_2 > R_3$
= $R_2 > R_1 > R_3$
~ $R_3 > R_2 > R_1$
~ $R_3 = R_1 + R_2$
~ $R_1 = R_2 + R_3$
}

Какие ЭКГ отведения относятся к двухполюсным {
=стандартные отведения I, II, III
~грудные отведения
~отведения от конечностей aVR, aVF, aVL
~все отведения
~двухполюсные отведения в настоящее время не применяются
}

Какие зубцы экг являются положительными укажите наиболее точный набор {
~P, Q, T
~Q, R, S
~R, S, T
~P, Q, R
=P, R, T
}

Каково соотношение зубцов r при отклонении электрической оси сердца влево (левограмме) {

= $R_1 > R_2 > R_3$

~ $R_1 > R_3 > R_2$

~ $R_2 > R_1 > R_3$

~ $R_3 > R_2 > R_1$

~ $R_1 = R_2 = R_3$

}

Какова величина угла альфа при вертикальном положении электрической оси сердца {

~ $0 - +30$

~ $30 - +60$

= $70 - +90$

~ $90 - +120$

~ $120 - +150$

}

При какой величине суммы зубцов r_1, r_2, r_3 говорят о снижении вольтажа экг {

~меньше 5 мм

~меньше 10 мм

=меньше 15 мм

~меньше 20 мм

~меньше 25 мм

}

Кто является основателем электро- кардиографического метода исследования {

~Чазов ЕК.

~Боткин СП.

~Пастер Л.

=Эйнтховен В.

~Ауэнбургер Л.

}

Каково направление зубца S {

~всегда направлен вверх

=всегда направлен вниз

~в 1 стандартном отведении направлен вверх, в остальных отведениях вниз

~в правых грудных отведениях направлен вверх

~в отведении aVR направлен вверх, в остальных отведениях вниз

}

В каком стандартном отведении наибольшая высота зубца r в норме {

~I

=II

~III

~III

~III

}

Какова максимальная амплитуда зубца Q в норме {

~1мм

~2мм

=3мм

~4мм

~5мм

}

Какому времени соответствует интервал между двумя тонкими линиями на записывающей ленте при скорости ее движения в 50 мм/сек {

~0,1 сек

~0,01 сек

=0,02 сек

~0,2 сек

~0,05 сек

}

Какие зубцы и интервалы составляют электрическую систолу сердца {

~P - Q

~QRS

~P - T

~S - T

=Q - T

}

Какой электрод является активным в отведении AVL {

~правая рука

=левая рука

~правая нога

~левая нога

~грудная стенка

}

Каково направление зубца S на ЭКГ {

~всегда направлен вверх

=всегда направлен вниз

~в I и II стандартных отведениях направлен вверх, в III вниз

~в правых грудных отведениях вниз, в левых вверх

~направлен вверх только в однополюсных отведениях от конечностей

}

К факторам риска ишемической болезни сердца относится {

~артериальная гипертония

~психоэмоциональные нагрузки

~курение

~ожирение

=все перечисленные

}

Непосредственной причиной возникновения приступа стенокардии может быть {

~волнение

~выход на холод

~физическая нагрузка

~повышение артериального давления

=все перечисленные

}

Стеноз устья аорты приводит {

~к повышению систолического давления в аорте

=к повышению давления в левом желудочке

~к увеличению минутного объема сердца

~к снижению давления в левом предсердии

~к легочной гипертензии

}

Больные с заболеваниями ссс не предъявляют жалобы на {

~боли в области сердца и за грудиной

~одышку

=кожный зуд

~сердцебиение.

~отёки на ногах

}

При каких состояниях не может возникать ослабление обоих тонов сердца {

~при ожирении

~при эмфиземе лёгких

~при левостороннем выпоте

~при выпотном перикардите

=после физической нагрузки

}

При каком пороке сердца систолический шум не выслушивается {

~недостаточность митрального клапана

~стеноз устья аорты

~недостаточность трёхстворчатого клапана

~стеноз лёгочной артерии

=стеноз левого предсердно-желудочкового отверстия

}

Как смещаются границы относительной сердечной тупости при митральном стенозе {

~влево

=вверх и вправо

~вверх и влево

~вправо и влево

~вправо

}

Какой аускультативный признак характерен для митрального стеноза {

=тон открытия митрального клапана

~ослабление I тона на верхушке

~ослабление II тона над клапаном аорты

~акцент II тона над аортой
~ослабление II тона над лёгочной артерией
}

Для аортального стеноза характерно {
~акцент II тона на аорте
=ослабление II тона на аорте
~систолический шум на верхушке
~положительный симптом Мюссе
~высокое систолическое давление
}

Для сердечных отеков характерно {
~появляются утром на лице
~отеки одной голени с локальным цианозом
=отеки голеней и стоп в конце рабочего дня
~односторонний инфраорбитальный отек
~отеки век, сопровождающиеся зудом
}

Шум трения перикарда можно выслушать у больных {
=с сухим перикардитом
~с острым гломерулонефритом
~с острым пиелонефритом
=с уремией
~с мочекаменной болезнью
}

Высокий и скорый пульс характерен для {
~недостаточности митрального клапана
=недостаточности клапанов аорты
~стеноза устья аорты
~недостаточности трехстворчатого клапана
~недостаточности клапанов легочной артерии
}

Тон открытия митрального клапана выслушивается при:
{ ~недостаточности митрального клапана
=стенозе левого атриовентрикулярного отверстия

~гипертрофии левого желудочка
~дилатации левого желудочка
~нарушении проведения возбуждения по ножкам пучка Гиса
~нарушении проведения возбуждения по ножкам пучка Гиса
}

При аортальной недостаточности выслушивается функциональный шум {
=Флинта
~Грехем-Стилла
~Риверо-Корвалло
~на легочной артерии
~на яремных венах
}

Левая граница относительной тупости образована
~ушком левого предсердия
~левым предсердием
=левым желудочком
~правым желудочком
~дугой аорты
}

Выраженная пульсация сонных артерий наблюдается у больных с {
~недостаточностью митрального клапана
~митральным стенозом
=недостаточностью клапанов аорты
~стенозом устья аорты
~стенозом устья аорты
}

"Пляска каротид" наблюдается при {
~левожелудочковой сердечной недостаточности
=недостаточности аортального клапана
~недостаточности трехстворчатого клапана
~правожелудочковой сердечной недостаточности
~недостаточности митрального клапана
}

Истинная пульсация печени и положительный венный пульс выявляются при

{
~недостаточности митрального клапана
~недостаточности аортального клапана
=недостаточности трехстворчатого клапана
~митральном стенозе
~инфаркте миокарда
}

Выраженная пульсация сонных артерий наблюдается у больных с {
~аортальным стенозом
=недостаточностью клапанов аорты
~недостаточностью митральных клапанов
~недостаточностью трехстворчатых клапанов
~недостаточностью клапанов легочной артерии
}

Увеличение пульсового давления наблюдается при {
~аортальном стенозе
=недостаточности клапанов аорты
~недостаточности митральных клапанов
~недостаточности трехстворчатых клапанов
~недостаточности клапанов легочной артерии
}

Появление отрицательного верхушечного толчка выявляется при {
~митральном стенозе
~гипертонической болезни
=слипчивом перикардите
~инфаркте миокарда
~кардиомиопатии
}

Двойной тон траубе бывает при {
~недостаточности митрального клапана
~митральном стенозе
=недостаточности клапанов аорты
~стенозе устья аорты
~недостаточности трехстворчатого клапана

}

Для приступа стенокардии характерно все за одним исключением {

~появление боли при физической нагрузке

~загрудинная локализация болей

~быстрый купирующий эффект нитроглицерина

~усиление приступов в холодную ветреную погоду

=пациент мечется от боли, не находит себе места.

}

Твердый пульс наблюдается при {

~недостаточности митрального клапана

=гипертонической болезни

~аортальном стенозе

~митральном стенозе

~левожелудочковой сердечной недостаточности

}

Укажите вид отеков по приведенным признакам: отеки диффузные, "плотные" локализуются преимущественно на голенях, стопах и в поясничной области, увеличиваются к вечеру, утром уменьшаются, сопровождаются выраженным акроцианозом {

= сердечные отеки

~почечные отеки

~аллергический отек

~воспалительный отек

~отеки при гипотиреозе (микседема)

}

В современную классификацию ИБС не внесены следующие формы: {

~стенокардия напряжения

~инфаркт миокарда

=диффузный кардиосклероз

~постинфарктный кардиосклероз

~первичная остановка сердца

}

Патологоанатомически при ИБС выявляется {

~вакулит

~гиалиноз сосудов

=атеросклероз коронарных сосудов

~миокардит

~амилоидоз сердца

}

При осмотре области сердца во время приступа стенокардии выявляется {

~сердечный горб

~сердечный толчок

~смещение верхушечного толчка влево и вниз

=отсутствие характерных изменений

}

Какие изменения лабораторных показателей выявляются при стабильной стенокардии напряжения? {

~лейкоцитоз.

~ускоренная СОЭ.

~повышение активности аминотрансфераз (АЛТ, АСТ).

=общий анализ крови не изменяется.

~повышение активности креатинфосфокиназы.

}

Чем в основном обусловлено наполнение пульса? {

~тонусом сосудистой стенки.

~периферическим сопротивлением сосудов.

=ударным объемом крови.

~напряжением сосудистой стенки.

}

Для какого заболевания характерны гектическая лихорадка, ознобы, обильное потоотделение, одышка, общая слабость? {

~для артериальной гипертензии.

=для инфекционного эндокардита.

~для миокардита.

~для инфаркта миокарда.

~для стенокардии.

}

Одышка при физических нагрузках у пациентов с заболеваниями сердца может быть признаком {

~бронхоспазма

~атриовентрикулярной блокады I степени

=сердечной левожелудочковой недостаточности

~блокады левой ножки пучка Гиса

~сосудистой недостаточности

}

Какой пульс характерен для недостаточности аортального клапана? {

=pulsus celer et altus.

~pulsus parvus.

~pulsus tardus et rarus.

~Pulsus paradoxus.

~Pulsus differens.

}

Какой пульс характерен для стеноза устья аорты? {

=pulsus parvus, tardus et rarus.

~pulsus celer et altus.

~pulsus paradoxus.

~pulsus differens.

~Pulsus parvus.

}

Назовите свойство пульса характерное для артериальной гипертензии. {

~мягкий.

~скорый.

~высокий.

~медленный.

=твердый.

}

Какое артериальное давление наиболее часто повышается при артериальной гипертензии? {

~только систолическое давление.

~только диастолическое давление.

=Систолическое и диастолическое давление.

~систолическое давление, а диастолическое давление снижается.

~пульсовое.

}

Наиболее частая причина развития атеросклероза? {

~туберкулезное повреждение сосудистой стенки.

~нарушение углеводного обмена.

=нарушение липидного обмена.

~нарушение белкового обмена.

~нарушение водно-электролитного обмена.

}

Третий тон сердца обусловлен колебанием {

~мышцы желудочков в систолу

~атриовентрикулярных клапанов в систолу

~полулунных клапанов в диастолу

=мышцы желудочков в диастолу во время быстрого пассивного наполнения

~ мышцы желудочков и предсердий в диастолу во время сокращения предсердий

}

Четвертый тон сердца обусловлен колебанием {

~атриовентрикулярных клапанов в систолу

~полулунных клапанов в диастолу

~миокарда желудочков в систолу

~ миокарда желудочков в диастолу во время быстрого пассивного наполнения

=миокарда желудочков и предсердий в диастолу во время сокращения предсердий

}

Как называется «мелодия» сердца, при выслушивании тона открытия митрального клапана? {

~ритм галопа пресистолический.

~ритм галопа протодиастолический.

=«ритм перепела».

~эмбриокардия.

}

Кажущееся раздвоение 2го тона на верхушке в «ритме перепела» обусловлено {

~неодновременным закрытием полулунных клапанов аорты и легочной артерии

~неодновременным закрытием атриовентрикулярных клапанов

~неодновременным сокращением миокарда желудочков

~усиленным третьим тоном сердца

=тоном открытия митрального клапана

}

Как называется ритм сердца, когда выслушивается усиленный 3-ий тон? {

~ритм галопа пресистолический.

=ритм галопа протодиастолический.

~ритм галопа мезодиастолический.

~эмбриокардия.

~ «ритм перепела».

}

Как называется ритм сердца, если выслушивается усиленный 4-ый тон? {

=ритм галопа пресистолический.

~ритм галопа протодиастолический.

~ритм галопа мезодиастолический.

~эмбриокардия.

~ «ритм перепела».

}

Функциональный диастолический шум Флинта выслушивается на {

=верхушке

~у мечевидного отростка

~на аорте

~на легочной артерии

~в точке Боткина

}

Функциональный диастолический шум Грэхема-Стилла выслушивается {

~на верхушке

~у мечевидного отростка

~в точке боткина

=на легочной артерии

~на аорте

}

О чем свидетельствует появление ритма галопа? {

~о митральном стенозе.

~о стенозе устья аорты.

~о недостаточности митрального клапана.

=о тяжелой сердечно-сосудистой недостаточности.

}

Для какого порока характерен «ритм перепела»? {

~для недостаточности митрального клапана.

~для недостаточности клапана аорты.

~для стеноза устья аорты.

=для стеноза левого атриовентрикулярного отверстия.

~для недостаточности трехстворчатого клапана.

}

Расширение границ абсолютной тупости сердца при митральном стенозе обусловлено увеличением размеров {

~левого предсердия

~левого желудочка

~левого предсердия и желудочка

~правого предсердия

=правого желудочка

}

При стенозе левого атриовентрикулярного отверстия левая граница относительной тупости сердца смещается кнаружи {

~только в 5-ом межреберье

~только 4-ом межреберье

~в 5-ом и 4-ом межреберьях

=в 3-ем межреберье

}

Какая конфигурация сердца характерна для митрального стеноза? {

~нормальная.

=митральная.

~аортальная.

~трапециевидная.

~ «бычье сердце».

}

Какая конфигурация сердца сравнительно часто выявляется при ИБС? {

~нормальная.

~митральная.

=аортальная.

~трапециевидная.

~ «бычье сердце».

}

Расположение каких границ относительной сердечной тупости чаще изменяется при ИБС? {

~правой.

=левой.

~верхней.

~изменяются все границы.

}

Изменение границ относительной тупости при ИБС обусловлено увеличением размеров {

~левого предсердия

=левого желудочка

~левого предсердия и желудочка

~правого предсердия

~правого желудочка

}

Левая граница относительной тупости сердца при ИБС смещается кнаружи {

~только в 5-ом межреберье

~только в 4-ом межреберье

=в 5-ом и 4-ом межреберьях одновременно

~в 3-ем межреберье

}

Какая конфигурация сердца сравнительно часто выявляется при инфаркте миокарда? {

~нормальная.

~митральная.

=аортальная.

~трапецевидная.

~ «бычье сердце».

}

Расположение каких границ относительной сердечной тупости изменяется при артериальной гипертензии? {

~правой.

=левой.

~верхней.

~изменяются все границы.

}

Изменение границ относительной тупости сердца при артериальной гипертензии обусловлено увеличением размеров {

~левого предсердия

=левого желудочка

~левого предсердия и желудочка одновременно

~правого предсердия

~правого желудочка

}

При артериальной гипертензии левая граница относительной тупости сердца смещается кнаружи {

~только в 5-ом межреберье

~только в 4-ом межреберье

=в 4-ом и 5-ом межреберье одновременно

~только в 3-ем межреберье

}

Расположение каких границ относительной сердечной тупости изменяется при недостаточности клапана аорты? {

~правой.

=левой.

~верхней.

~изменяются все границы.

}

Границы относительной тупости сердца при недостаточности аортального клапана изменяются из-за увеличения размеров {

~левого предсердия

=левого желудочка

~левого предсердия и желудочка

~правого предсердия

~правого желудочка

}

Левая граница относительной тупости сердца при недостаточности клапана аорты смещается кнаружи {

~только в 5-ом межреберье

~только в 4-ом межреберье

=в 5-ом и 4-ом межреберьях одновременно

~в 3-ем межреберье

~все ответы правильные

}

Границы относительной тупости сердца при первичном ревмокардите {

~не изменяются

~изменяются за счет гипертрофии миокарда

=изменяются за счет миогенной дилатации

~изменяются за счет гипертрофии и дилатации

}

Какие границы относительной сердечной тупости чаще всего изменяются при первичном ревмокардите? {

=левая.

~все перечисленные.

~правая.

~верхняя.

}

Чаще всего изменение границ относительной сердечной тупости при ревмокардите происходит из-за увеличения размеров {

~левого предсердия

~правого предсердия

=левого желудочка

~правого желудочка

~левого и правого желудочков

}

Левая граница относительной тупости сердца при первичном ревмокардите смещается кнаружи {

~только в 5-ом межреберье

~только в 4-ом межреберье

=в 5-ом и 4-ом межреберьях одновременно

~в 3-ем межреберье

~во 2-ом межреберье

}

Изменение границ относительной тупости сердца при недостаточности митрального клапана обусловлено увеличением размеров {

~только левого предсердия

~только левого желудочка

=левого предсердия и желудочка

~восходящего отдела аорты

~только правого желудочка

}

Верхняя граница относительной тупости сердца при недостаточности митрального клапана может находиться {

~на 3-ем ребре

~в 3-ем межреберье

=выше 3-го ребра

~ниже 3-го ребра

}

«Талия» сердца соответствует месту проекции на грудную клетку{

~левого желудочка

~правого желудочка

=ушка левого предсердия

~правого предсердия

}

При какой конфигурации сердца «талиа» сердца резко выражена? {

~митральной.

=аортальной.

~нормальной.

~трапециевидной.

}

Данные перкуссии во время приступа стенокардии {

~левая граница относительной сердечной тупости смещена влево.

~верхняя граница относительной сердечной тупости смещена вверх.

=границы не изменены.

~правая граница смещена вправо.

~границы смещены вверх и вправо

}

Каковы границы относительной сердечной тупости при стенозе устья аорты? {

~правая смещена вправо.

~верхняя смещены вверх.

~левая смещена в 3 межреберье кнаружи.

=левая смещена влево в 4-6 межреберье.

~верхняя смещена книзу.

}

Какой биохимический маркер предпочтителен для диагностики инфаркта миокарда: {

~гамма-глутамилтранспептидаза.

~аланинаминотрансфераза (АЛТ).

=тропонин I.

~щелочная фосфатаза.

~С-реактивный белок.

}

Какой показатель сыворотки крови является наиболее ранним маркером некроза сердечной мышцы: {

~МВ-фракция креатинфосфокиназы.

=тропонин I.

~лактатдегидрогеназа (ЛДГ).

~аспартатаминотрансфераза (АСТ).

}

Какой признак, выявляемый ультразвуковым методом, является маркером инфекционного эндокардита: {

~ расширение камер сердца.

~ снижение сократительной способности миокарда левого желудочка.

= вегетации на клапанах.

~ очаговый гипокинез миокарда.

}

Блок В (25%)_

ТЗ

ТЗ Форма 2²

Для митрального стеноза характерна следующая аускультативная симптоматика {

~ 33.33333% хлопающий I тон на верхушке сердца

~ 50% акцент II тона на верхушке сердца

~ 33.33333% щелчок открытия митрального клапана

~ 33.33333% протодиастолический и пресистолический шумы на верхушке сердца

~ 50% систолический шум на верхушке сердца

}

Признаками преобладания митрального стеноза при сочетанном митральном пороке сердца являются {

~ 50% выраженный систолический шум на верхушке сердца

~ 50% ослабление I тона на верхушке сердца

~ 33.33333% хлопающий I тон на верхушке сердца

~ 33.33333% наличие III тона (щелчка открытия митрального клапана)

~ 33.33333% интервал Q - I тон - 0.09 с

}

При остром инфаркте миокарда в сыворотке крови раньше других возрастает уровень активности {

~ 33.33333% аспарагиновой трансаминазы (АСТ)

~ 50% креатинкиназы МВ

~ 33.33333% лактатдегидрогеназы (ЛДГ)

~%-33.33333% аланиновой трансаминазы (АЛТ)
~%-50% миоглобина, тропонинов
}

Диастолические шумы выслушиваются при следующих пороках {
~%-50% при недостаточности митрального клапана
~%-33.33333% при митральном стенозе
~%-50% при аортальном стенозе
~%-33.33333% при недостаточности аортальных клапанов
~%-33.33333% при комбинированных пороках
}

Наиболее важными факторами риска ишемической болезни сердца являются {
~%-50% желчнокаменная болезнь
~%-33.33333% алкоголизм
~%-33.33333% артериальная гипертензия
~%-50% азотемия
~%-33.33333% диабет
}

Критериями систолического шума являются {
~%-33.33333% лучше проводятся в стороне от места своего образования
~%-50% лучше проводятся по направлению тока крови
~%-50% лучше выслушиваются в горизонтальном положении
~%-33.33333% не проводятся дальше места возникновения
~%-33.33333% проводятся по направлению к верхушке сердца
}

Какие из симптомов объективного обследования области сердца характерны для недостаточности аортального клапана {
~%-33.33333% усиленный и разлитой верхушечный толчок
~%-33.33333% втяжение и выбухание межреберных пространств, примыкающих к верхушечному толчку
~%-50% систолическое дрожание во втором межреберье справа от грудины
~%-50% расширение перкуторных границ сосудистого пучка
~%-33.33333% пульсация дуги аорты в яремной ямке
}

Ревматизм - это системное воспалительное заболевание соединительной ткани, наиболее характерными признаками, которого являются {
~%50% преимущественное поражение сердечно-сосудистой системы
~%33.33333% частое поражение суставов, ЦНС, кожи
~%33.33333% наличие генетически обусловленного дефекта иммунной системы
~%33.33333% инфицирование бета-гемолитическим стрептококком группы А
~%50% прямое токсическое действие стрептококка на миокард
}

Ведущая роль бета-гемолитического стрептококка в этиологии ревматизма подтверждается
~%50% стафилококк
~%50% обнаружением бета-гемолитического стрептококка в синовиальной жидкости и биоптате эндокарда
~%33.33333% повышением титра антистрептококковых антител (антистрептолизин-0, антистрептогиалуронидаза, антистрептокиназа)
~%33.33333% профилактикой обострений ревматизма с помощью антибиотиков
~%33.33333% схожестью антигенного строения стрептококка и соединительной ткани сердца, что приводит к перекрестным, в том числе аутоиммунным, реакциям
}

Характерным признаком ревматизма, позволяющим поставить диагноз, является {
~%33.33333% связь заболевания с перенесенной носоглоточной инфекцией
~%33.33333% наличие латентного периода длительностью 2-4 недели
~%33.33333% появление первых признаков заболевания в детском возрасте
~%50% все перечисленное
~%50% анкилоз одного или нескольких суставов
}

Развитию ревматизма способствуют: {
~%33.33333% низкий социальный уровень жизни
~%50% урогенитальная инфекция
~%33.33333% частые охлаждения
~%50% парагрипп

~%33.33333% хронический тонзиллит у нескольких членов семьи,
проживающих вместе
}

Какие заболевания могут привести к недостаточности аортального клапана
{
~%33.33333% ревматизм
~%33.33333% инфекционный эндокардит
~%-50% гипертоническая болезнь
~%-50% миокардит
~%33.33333% атеросклероз аорты
}

Признаками преобладания недостаточности митрального клапана при
митральном пороке сердца являются {
~%33.33333% ослабление I тона на верхушке сердца
~%-50% мерцательная аритмия
~%33.33333% продолжительный систолический шум на верхушке сердца
~%33.33333% гипертрофия левого желудочка
~%-50% ритм "перепела"
}

Для недостаточности аортального клапана характерны {
~%33.33333% ослабление I тона на верхушке сердца
~%33.33333% ослабление II тона на основании сердца
~%33.33333% протодиастолический шум в зоне проекции аортального
клапана
~%-50% признаки гипертрофии правого желудочка на ЭКГ
~%-50% мерцательная аритмия
}

Охарактеризуйте АД и пульс у больных с недостаточностью аортального
клапана {
~%-33.33333% низкое пульсовое давление
~%-33.33333% несимметричное АД на обеих руках
~%50% высокое пульсовое давление
~%50% пульс высокий и скорый
~%-33.33333% пульс медленный и слабого наполнения
}

Место наилучшего выслушивания протодиастолического шума при недостаточности аортальных клапанов {

~%-33.33333% второе межреберье слева от грудины

~%50% второе межреберье справа от грудины

~%50% точка Боткина-Эрба

~%-33.33333% верхушка сердца

~%-33.33333% сосуды на шее

}

При каких условиях могут не прослушиваться шумы при пороках сердца {

~%-50% при выраженной брадикардии

~%33.33333% при выраженной тахикардии

~%33.33333% при мерцательной аритмии

~%-50% при блокадах сердца

~%33.33333% при развитии слабости сердечной мышцы (недостаточности сердца)

}

Какие клинические симптомы зависят от быстрого подъема и снижения диастолического давления в аорте {

~%33.33333% двойной шум Траубе и Дюрозье на периферических сосудах

~%-50% усиленный разлитой верхушечный толчок

~%-50% диастолический шум

~%33.33333% капиллярный пульс

~%33.33333% высокий и скорый пульс

}

Для каких пороков сердца характерен хлопающий первый тон {

~%-33.33333% недостаточность митрального клапана

~%50% стеноз атриовентрикулярного отверстия

~%-33.33333% стеноз устья аорты

~%-33.33333% недостаточность аортального клапана

~%50% комбинированный митральный порок с преобладанием стеноза

}

Причинами ослабления первого тона на верхушке являются {

~%50% недостаточность митрального клапана

~%50% недостаточность аортального клапана

~%33.33333% стеноз левого атриовентрикулярного отверстия (митральный стеноз)
~%33.33333% стеноз легочной артерии
~%33.33333% комбинированный митральный порок
}

При анатомических изменениях клапанного аппарата сердца возникает следующий шум {

~%33.33333% систолический
~%50% функциональный
~%33.33333% пресистолический
~%33.33333% протодиастолический
~%50% экстакардиальный
}

Причины ослабления второго тона на аорте {

~%33.33333% недостаточность клапанов аорты
~%33.33333% уменьшение кровенаполнения аорты
~%50% сужение митрального отверстия
~%33.33333% стеноз устья аорты
~%50% недостаточность митрального клапана
}

Диастолические шумы могут быть {

~%50% органическими (как правило)
~%50% функциональными (изредко)
~%33.33333% и функциональными и органическими
~%33.33333% сердечного генеза
~%33.33333% внесердечного генеза
}

Систолический шум встречается при следующих приобретенных и врожденных пороках сердца

~%50% митральный стеноз
~%33.33333% стеноз устья аорты
~%50% недостаточность клапанов аорты
~%33.33333% недостаточность митрального клапана
~%33.33333% корактация аорты
}

Мерцательная аритмия встречается наиболее часто при {

~%33.33333% митральном стенозе

~%33.33333% безболевого ИБС

~%33.33333% при тиреотоксикозе

~%-50% при недостаточности митрального клапана

~%-50% при гипотиреозе

}

Какие из перечисленных утверждений верны {

~%-33.33333% мерцательная аритмия не приводит к ХСН

~%50% мерцательная аритмия опасна тем, что таит угрозу
тромбоэмболических осложнений

~%50% мерцательная аритмия имеет две формы -хроническую (постоянную)
и острую пароксизмальную (рецидивирующую)

~%-33.33333% мерцательная аритмия не опасна для жизни

~%-33.33333% мерцательная аритмия - первичная нозологическая единица

}

Зубец Q на экг здорового человека отражает {

~%33.33333% возбуждение межпредсердной перегородки

~%33.33333% возбуждение основания правого желудочка

~%33.33333% возбуждение внутренней поверхности желудочков

~%-50% время активации левого желудочка

~%-50% электрическую систолу желудочков

}

Диагноз "брадикардия" устанавливается на основании {

~%-33.33333% анамнестических данных

~%50% данных ЭКГ-исследования

~%-33.33333% жалоб больного

~%-33.33333% результатов рентгенологического исследования

~%50% аускультации и подсчета пульса

}

К основным электрокардиографическим признакам синусовой брадикардии относятся {

~%-33.33333% урежение сердечного ритма до 70 в минуту

~%50% урежение сердечного ритма до 40-59 в минуту

~%50% сохранение правильного синусового ритма
~%33.33333% возникновение периодов Самойлова - Венкебаха
~%33.33333% суточные колебания пульса от 50 до 120
}

Причиной развития синусовой брадикардии являются {
~%50% дисфункция коркового вещества надпочечников
~%33.33333% повышение тонуса блуждающего нерва
~%33.33333% понижение тонуса симпатической нервной системы
~%33.33333% прием ряда медикаментов
~%50% блокада предсердных проводящих путей
}

Для преобладания стеноза при наличии признаков комбинированного митрального порока характерны симптомы {
~%33.33333% ослабление 1 тона
~%50% усиление 1 тона
~%50% правый тип ЭКГ
~%33.33333% нормограмма
~%33.33333% акцент 2 тона на аорте
}

При осмотре больного стенозом левого атриовентрикулярного отверстия можно выявить {
~%50% ожирение, бледность щек
~%50% истощение, цианоз губ, румянец щек
~%50% одышку
~%50% пульсацию каротид, отеки ног
}

Основные жалобы больных стенозом левого атриовентрикулярного отверстия {
~%50% боли за грудиной
~%50% одышка
сердцебиение
~%50% сонливость
~%50% головокружение
}

Выберите наиболее важные аускультативные признаки недостаточности митрального клапана {

- ☐-33.33333% диастолический шум
 - ☐50% систолический шум на верхушке
 - ☐-33.33333% акцент 2 тона на аорте
 - ☐50% ослабление 1 тона на верхушке
 - ☐-33.33333% усиление 2 тона во 2 межреберье справа
- }

Факторы, повышающие риск развития ИБС {

- ☐-50% повышение уровня липопротеидов высокой плотности
 - ☐33.33333% сахарный диабет
 - ☐33.33333% артериальная гипертензия
 - ☐33.33333% наследственная отягощенность
 - ☐-50% гипохолестеринемия
- }

Какой из перечисленных лабораторных показателей подтверждает развитие инфаркта миокарда в первые 4 часа от начала заболевания {

- ☐-33.33333% АСТ
 - ☐50% Креатинкиназа МВ
 - ☐-33.33333% ЛДГ
 - ☐-33.33333% Щелочная фосфатаза
 - ☐50% Тропонины 1 и 2
- }

В повышении АД участвуют следующие механизмы {

- ☐33.33333% увеличение сердечного выброса
 - ☐33.33333% задержка натрия
 - ☐33.33333% увеличение активности ренина
 - ☐-50% уменьшение сердечного выброса
 - ☐-50% повышение венозного давления
- }

Причиной мерцательной аритмии могут быть нижеперечисленные заболевания {

- ☐-50% нейроциркуляторная дистония
- ☐-50% ревматизм
- ☐50% ИБС

~%50% тиреотоксикоз
}

Наиболее достоверным признаком стеноза левого атриовентрикулярного отверстия является {

~%-33.33333% увеличение левой границы сердца
~%50% диастолический шум в области верхушки
~%-33.33333% наличие мерцательной аритмии
~%50% наличие "щелчка открытия" митрального клапана
~%-33.33333% сглаженность талии сердца при рентгенологическом исследовании
}

Ослабление 1-го тона наблюдается, как правило, при следующих пороках сердца {

~%50% недостаточности митрального клапана
~%50% недостаточности аортального клапана
~%-50% стенозе левого атриовентрикулярного отверстия
~%-50% аортальный стеноз
}

Что из представленного соответствует признакам правожелудочковой недостаточности {

~%50% увеличение печени
~%-50% снижение венозного давления
~%50% замедление скорости кровотока
~%-50% цианоз
}

Какие признаки соответствуют отклонению оси сердца вправо {

~%-33.33333% высокий R и глубокий S в V1
~%50% высокий R и низкий S в V3
~%-33.33333% высокий R и глубокий S в V1
~%50% низкий R и глубокий S в V1
~%-33.33333% высокий R и глубокий S в V2
}

Выберите наиболее значимые факторы риска развития артериальной гипертензии {

~%50% наследственная предрасположенность
~%50% избыточная масса тела
~%33.33333% избыточное потребление овощей
~%33.33333% избыточное потребление белка
~%33.33333% гипотрофия
}

Какие из указанных изменений экг характерны для стенокардии {
~%33.33333% патологический зубец Q
~%33.33333% подъем сегмента ST
~%50% депрессия сегмента ST
~%50% появление симметричного отрицательного зубца T
~%33.33333% преходящая блокада ножек пучка Гиса
}

Для ангиоспастической стенокардии характерно {
~%33.33333% ночной характер стенокардии покоя
~%33.33333% стереотипность возникновения болей
~%33.33333% подъем ST в период болей
~%50% появление отрицательного T в период боли
~%50% появление AV блокады
}

Какие признаки при стенокардии напряжения дают основание заподозрить возникновение инфаркта миокарда {
~%50% длительность не боли более 15 минут
~%33.33333% появление страха смерти
~%33.33333% падение АД
~%33.33333% боль сильнее предыдущих приступов
~%50% длительность 5 минут
}

Повышение каких сывороточных ферментов наблюдается в первые 6-12 часов инфаркта миокарда {
~%33.33333% креатининкиназы MB
~%50% лактатдегидрогеназы
~%33.33333% АСТ
~%50% щелочной фосфатазы
~%33.33333% тропонина 1 и 2

}

При каких заболеваниях чаще всего встречается диастолический шум в области сердца {

~%50% аортальная недостаточность

~%-33.33333% миокардит

~%50% митральный стеноз

~%-33.33333% аотральный стеноз

~%-33.33333% инфаркт миокарда

}

Какие признаки могут наблюдаться как при инфаркте миокарда, так и при миокардите {

~%33.33333% глухие тоны сердца

~%33.33333% боли в области сердца

~%33.33333% тахикардия

~%-50% внезапное появление систолического шума

~%-50% чувство страха смерти

}

Для систолического шума митральной регургитации характерно {

~%-33.33333% грубый скребущий, иногда сопровождающийся

систолическим дрожанием

~%-33.33333% эпицентр звучания - верхушка или точка Боткина

~%50% проводится в левую подмышечную область или вверх вдоль левого края грудины

~%50% отмечается постоянством и меньшей зависимостью от фаз дыхания, положения тела и физической нагрузки

~%-33.33333% может усиливаться в положении на правом боку, после вдоха

}

Какие из перечисленных признаков характерны для митрального стеноза {

~%-33.33333% систолический шум на верхушке сердца, усиливающийся на выдохе

~%50% хлопающий I тон

~%-33.33333% акцент и раздвоение II тона над аортой

~%-33.33333% систолический шум на верхушке сердца, усиливающийся на вдохе

~%50% дополнительный высокочастотный тон в диастоле, отстоящий от II

тона на 0,07-0,12 секунд

}

Больные с митральным стенозом могут предъявлять жалобы {

~%33.33333% на приступы удушья по ночам

~%33.33333% на приступы сердцебиения

~%-50% на головокружение и обмороки

~%-50% на сжимающие боли за грудиной при ходьбе

~%33.33333% на кровохарканье

}

Для клинических проявлений аортальной недостаточности характерно следующее {

~%50% длительное время жалобы могут отсутствовать

~%50% в стадии декомпенсации появляются жалобы на одышку

~%-33.33333% обязательно развитие мерцательной аритмии

~%-33.33333% часто развивается стенокардия

~%-33.33333% часто наблюдаются головокружения и обмороки

}

Патофизиологические нарушения при митральной недостаточности {

~%33.33333% обратный ток крови из левого желудочка в левое предсердие

~%-50% развитие дилатации левого желудочка, преобладающей над гипертрофией

~%33.33333% постепенное развитие выраженной гипертрофии левого желудочка

~%-50% гипертрофия правого желудочка

~%33.33333% постепенное увеличение объема левого предсердия

}

Какие признаки позволяют думать о присоединении к митральной недостаточности недостаточности трикуспидального клапана {

~%33.33333% систолическая пульсация печени

~%33.33333% положительный венный пульс

~%-50% расширение легочной артерии

~%-50% смещение верхушечного толчка кнаружи от срединно-ключичной линии

~%33.33333% эпигастральная пульсация

}

Норма пульсового давления и как оно изменяется при стенозе устья аорты {
~%50% 40 - 50 мм рт. ст.
~%-33.33333% 60 - 70 мм рт. ст.
~%50% уменьшается
~%-33.33333% увеличивается
~%-33.33333% не изменяется
}

Диагноз " брадикардия" устанавливается на основании {
~%-33.33333% результатов рентгенологического исследования
~%-33.33333% анамнестических данных
~%50% данных ЭКГ исследования
~%-33.33333% жалоб больного
~%50% аускультации
}

Какие утверждения в отношении аускультации сердца верны {
~%33.33333% последовательность выслушивания сердца обусловлена частотой поражения клапанов сердца
~%33.33333% от приобретённых пороков сердца чаще всего страдает митральный клапан
~%33.33333% в норме у здорового человека на всех пяти классических точках аускультации выслушиваются два тона
~%-50% после I тона следует большая пауза
~%-50% после II тона следует малая пауза
}

При каких состояниях возникает ослабление i тона на верхушке сердца {
~%-50% при митральном стенозе
~%33.33333% при недостаточности митрального клапана
~%33.33333% при недостаточности клапанов аорты
~%33.33333% при сердечной недостаточности
~%-50% при стенокардии
}

Что правильно в отношении ii тона на основании сердца {
~%50% в норме у взрослого громкость II тона над клапаном аорты и клапаном лёгочного ствола одинакова

~%50% акцент II тона над аортой возникает при артериальной гипертензии
~%-50% ослабление II тона над аортой наблюдают при атеросклерозе
клапанов аорты
~%-50% ослабление II тона над лёгочной артерией соответствует стенозу
устья аорты
}

При расспросе больного с жалобой на боли в области сердца необходимо
выяснить {
~%-50% связь с употреблением алкоголя
~%33.33333% точную локализацию болей
~%33.33333% характер
~%33.33333% продолжительность
~%-50% связь с инфекцией бета-гемолитическим стрептококком группы А
}

Выберите признаки сердечной недостаточности с застоем крови по
большому кругу кровообращения {
~%-50% сердечная астма
~%33.33333% увеличение печени
~%-50% положение с возвышенным изголовьем
~%33.33333% отёки на ногах
~%33.33333% положительный симптом Плеша (набухание шейных вен при
надавливании на область печени (гепатоюгулярный рефлюкс)
}

Укажите, какие свойства шума оценивают при выслушивании сердца {
~%33.33333% фазу сердечного цикла (систола, диастола), в которой
возникает шум
~%-50% место наименьшего выслушивания
~%33.33333% проведение шума
~%33.33333% характер шума
~%-50% внесердечный характер шума
}

Что характерно для функционального шума над областью сердца {
~%33.33333% изменяется по звучности, особенно при изменении положения
тела, при дыхании
~%33.33333% изменяется при нагрузке

~%33.33333% встречается часто у молодых людей и детей
~%-50% обусловлен увеличением вязкости крови и уменьшением скорости кровотока
~%-50% выслушивается при врождённом пороке сердца
}

Какой метод наиболее надёжен для подтверждения стеноза коронарных артерий {

~%-33.33333% ЭКГ
~%-33.33333% ЭКГ с дозированной физической нагрузкой
~%-33.33333% сцинтиграфия после физической нагрузки
~%50% коронароангиография
~%50% спиральная цифровая КТ сердца
}

Выберите верные утверждения {

~%33.33333% дефицит пульса определяют как разницу между ЧСС и пульсом, он характерен для мерцательной аритмии
~%33.33333% скачущий, высокий pulsus celer et altus характерен для недостаточности клапанов аорты
~%33.33333% медленный вялый, малого наполнения pulsus tardus et parvus характерен для стеноза устья аорты
~%-50% напряжённый твёрдый pulsus durus соответствует низкому АД
~%-50% малый мягкий pulsus filiformis соответствует высокому АД
}

Мерцательная аритмия часто возникает у больных {

~%-33.33333% гипертонической болезнью 1 стадии
~%50% митральным стенозом
~%-33.33333% аортальным стенозом
~%-33.33333% недостаточностью клапанов аорты
~%50% тиреотоксикозом

Факторы, способствующие появлению функциональных шумов в сердце {

~%50% ускорение тока крови
~%-33.33333% сгущение крови
~%50% разжижение крови
~%-33.33333% заболевание суставов

~%-33.33333% органические поражения клапанаов и отверстий
}